การประชุมนำเสนอผลการศึกษาและเสวนานโยบาย · 26 ตุลาคม 2569

ความก้าวหน้า ไม่ได้เกิดขึ้นเอง

ข้อค้นพบและข้อเสนอเชิงนโยบาย จากโครงการวิจัย
การพัฒนาแนวทางและนโยบายการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพ
โดยใช้แบบจำลองแบบบูรณาการ

นพ.พีรสิชฌ์ สิทธิรัตน์ หัวหน้าโครงการ
หน่วยวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



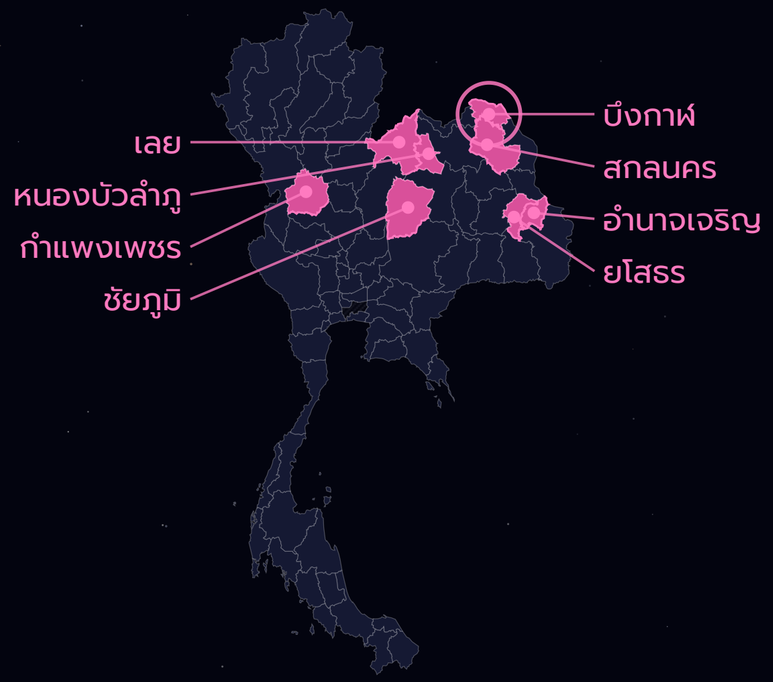
101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สิบสองปีที่ผ่านมา · ผลจากข้อมูล

ความก้าวหน้าเป็นของจริง

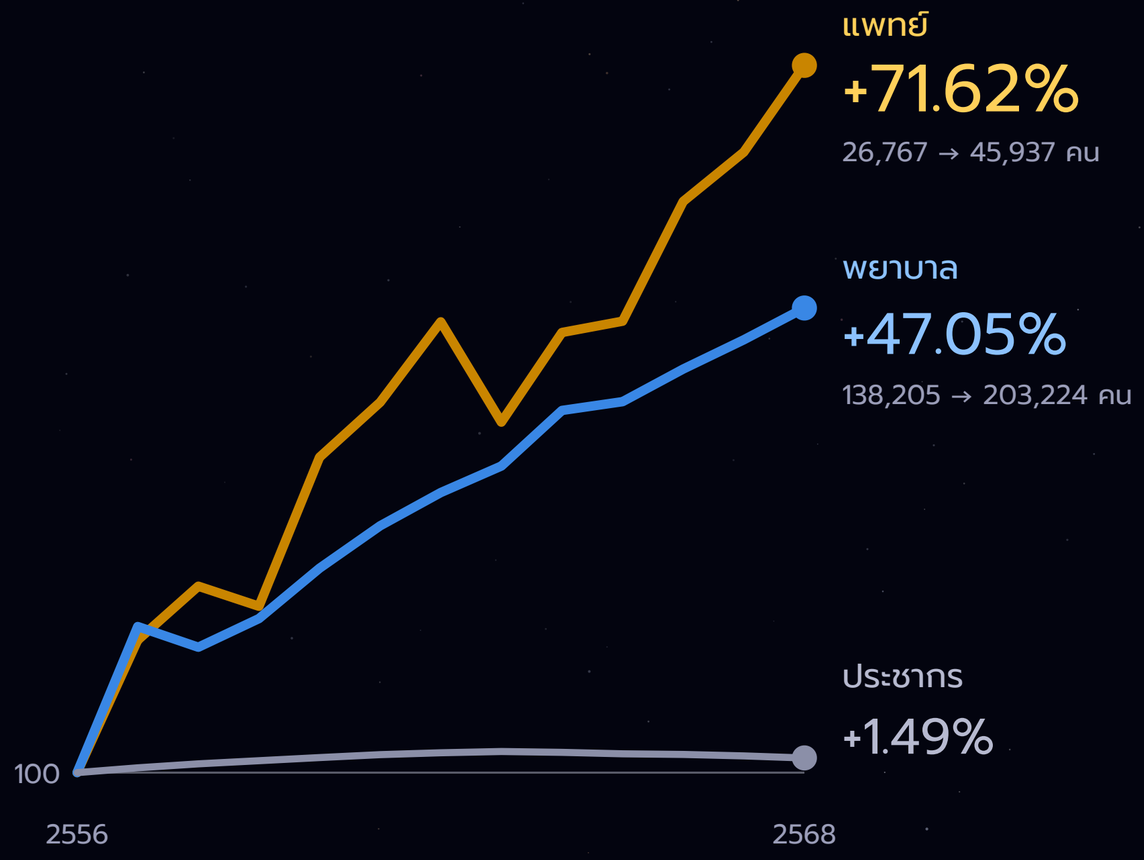
แพทย์และพยาบาลเพิ่มเร็วกว่าประชากรมาก
แต่บางพื้นที่ยังมีคนให้บริการน้อย

8 จังหวัดมีแพทย์กระทรวงเทียบฐานวัด**ต่ำทั้งสี่วิธี** รวมบึงกาฬ
คำถามจึงอยู่ที่ว่า คนเพิ่มขึ้นแล้ว แต่ทำไมบางพื้นที่ยังขาด



เพิ่มขึ้นเท่าใดจากปี 2556

ให้ปี 2556 เริ่มที่ 100 เท่ากัน



บุคลากรทุกสังกัด พ.ศ. 2556–2568 (รายงานทรัพยากรสาธารณสุข) · พยาบาลวิชาชีพรวมพยาบาลเทคนิค · ประชากรจากทะเบียนราษฎรรายอายุ · แผนที่: แพทย์กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มต่ำสุดทั้งสี่วิธีวัด · รายงานการศึกษา บทที่ 4

101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

แผนที่ของเรื่องวันนี้ · แผนภาพเชิงแนวคิด

มีสิทธิรับบริการแล้ว ต้องมีคนทำงานรองรับ

ประชาชนจะได้รับบริการ เมื่อสิทธิที่กำหนดไว้มีคนทำงานรองรับ ตั้งแต่การฝึก การจ้าง จนถึงการทำงานอยู่ต่อได้

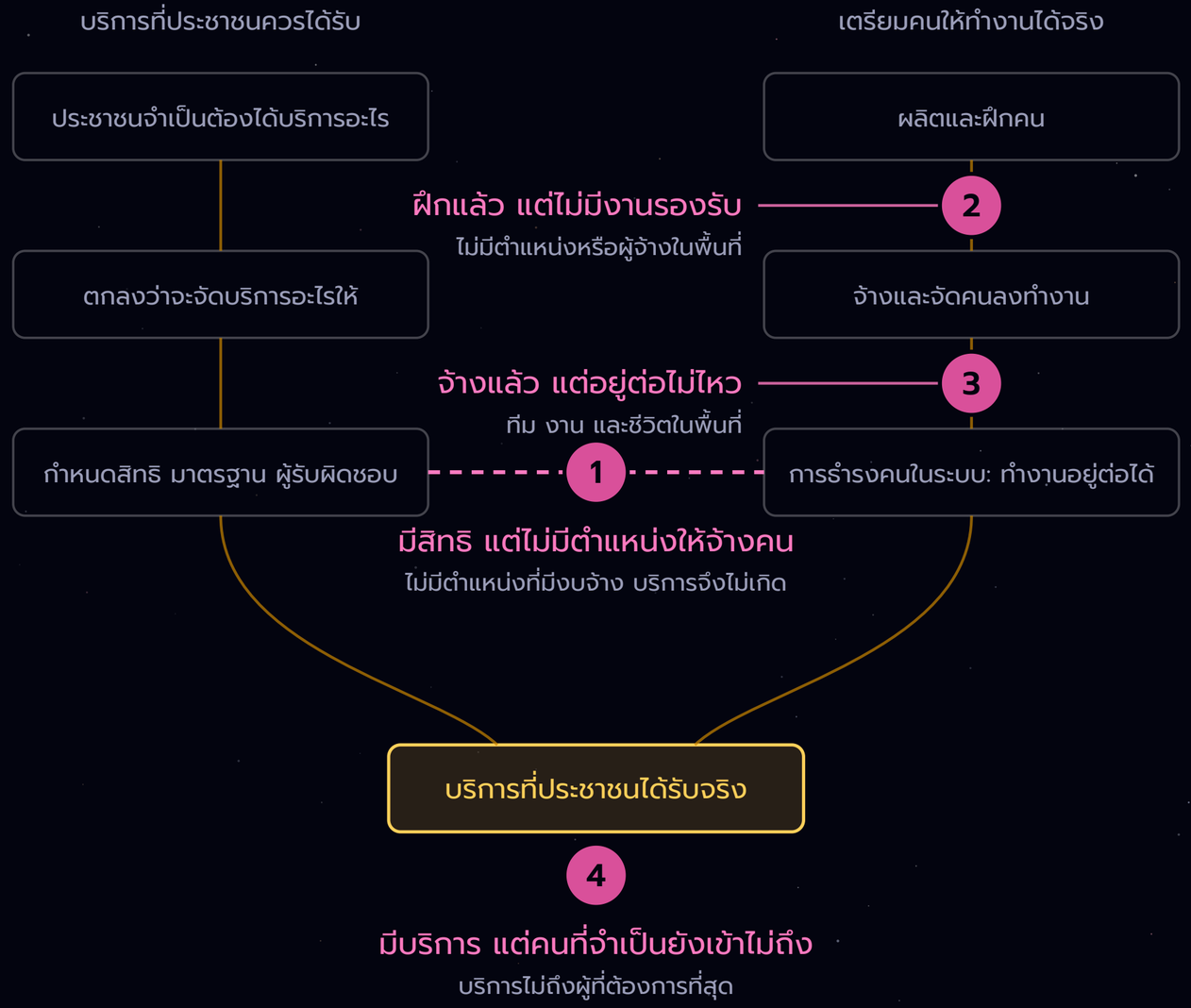
ต้องกำหนดบริการและเตรียมคนให้ทำงานรองรับ
จึงจะเกิดบริการที่ประชาชนได้รับจริง
การบรรยายวันนี้มีสี่ช่วง

หนึ่ง
นับอย่างไร

สอง
ทำไมความเหลื่อมล้ำสะสม

สาม
เพิ่มตำแหน่งให้พื้นที่ขาด

สี่
ใครรับภาระ



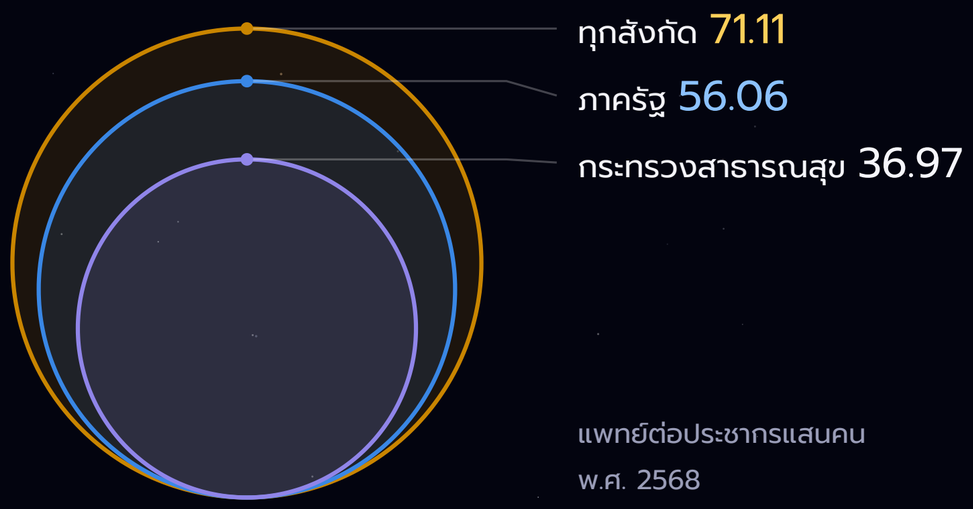
101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ผลจากข้อมูล

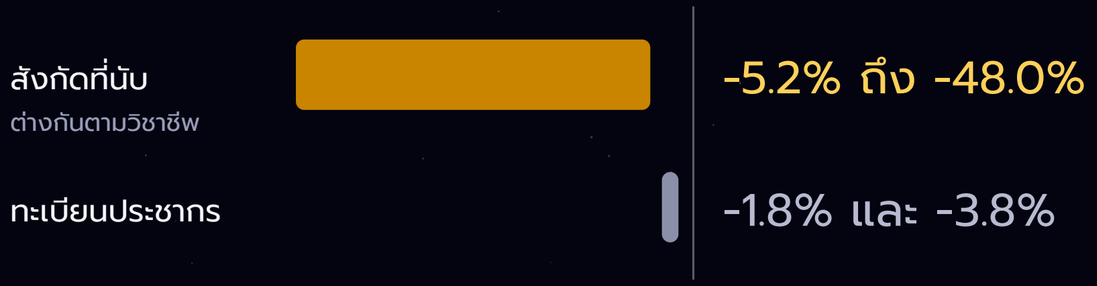
หมอพอไหม ต้องบอกว่านับใคร และเทียบกับอะไร

นับเฉพาะหมอกระทรวง หรือรวมรัฐและเอกชนด้วย ได้คำตอบต่างกันมาก

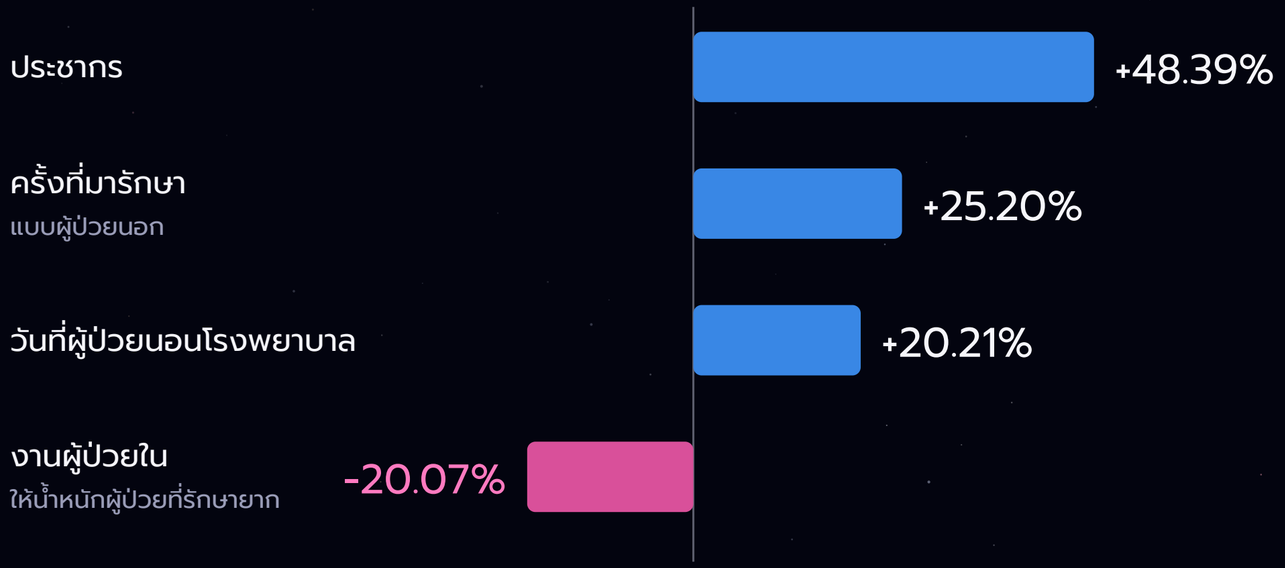
แพทย์กระทรวงชุดเดียวกัน เทียบกับประชากรเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.39
แต่เทียบกับงานผู้ป่วยในที่ให้น้ำหนักผู้ป่วยที่รักษายาก**ลดลงร้อยละ 20.07**



บุคลากรต่อประชากรลดลงเท่าใด เมื่อเปลี่ยนสิ่งที่นับ (%)



แพทย์กระทรวงชุดเดียวกัน เทียบกับอะไรจึงเห็นว่าเพิ่มหรือลด (%)



แพทย์ต่อประชากรแสนคน พ.ศ. 2568 · ช่วงยาว พ.ศ. 2556–2568 ยกเว้นงานผู้ป่วยใน (AdjRW) ปีงบ 2561–2568 ซึ่งส่วนหนึ่งเกี่ยวกับการเปลี่ยนระบบจัดกลุ่มโรค
· รายงานการศึกษา บทที่ 4

101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

หนึ่ง · นับอย่างไร ● ผลจากข้อมูล

เปลี่ยนไม้บรรทัด รายชื่อจังหวัดที่ขาด ก็เปลี่ยน

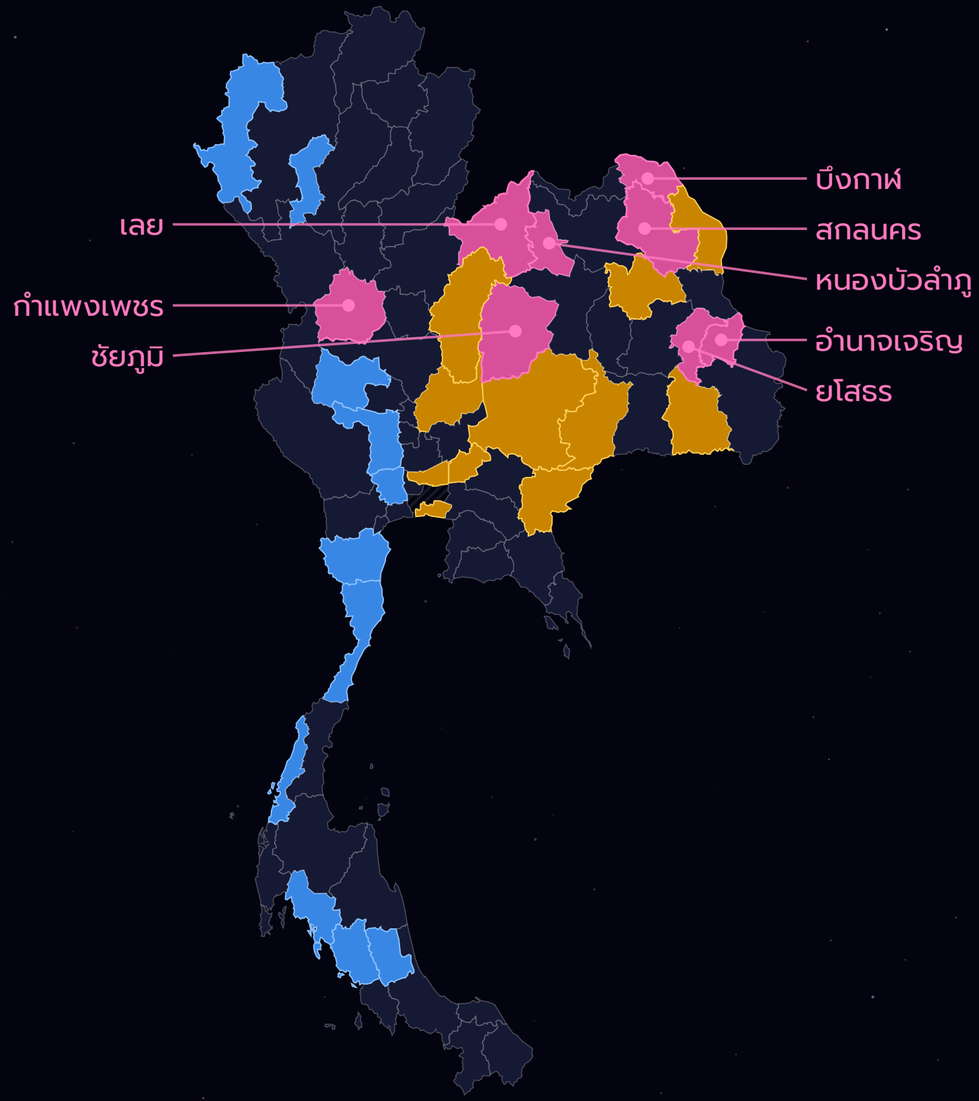
เทียบแพทย์กระทรวงของ 76 จังหวัดกับฐานวัดหกแบบ แล้วดูว่า 19 จังหวัดที่ได้ค่าต่ำสุดเปลี่ยนหรือไม่

8 จังหวัดที่ต่ำทั้งสี่วิธีควรได้รับความสำคัญก่อน
ส่วนจังหวัดที่ผลต่างกันต้องตรวจเพิ่ม

สี่ฐานหลัก

ประชากร · บริการที่ทำจริง · บริการที่แบบจำลองปรับให้เทียบกันได้ · ภาระโรค

- ต่ำทั้งสี่วิธี 8 จังหวัด
- ต่ำเมื่อเทียบภาระโรค แต่ไม่ต่ำเมื่อเทียบบริการ 11 จังหวัด
- ต่ำเมื่อเทียบบริการ แต่ไม่ต่ำเมื่อเทียบภาระโรค 11 จังหวัด



101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

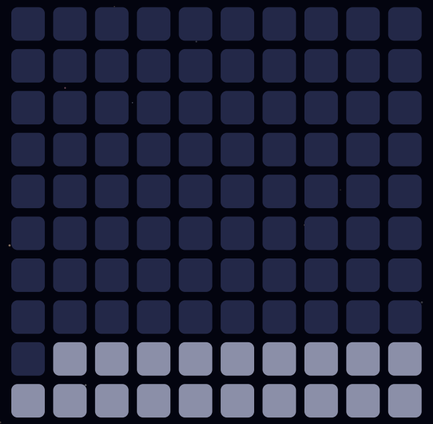
หนึ่ง · นับอย่างไร ● ผลจากข้อมูล

จังหวัดที่ป่วยมาก มักมีหมอน้อย

สังคมสูงวัย เจ็บป่วยเพิ่มแม้คนเพิ่มไม่มาก

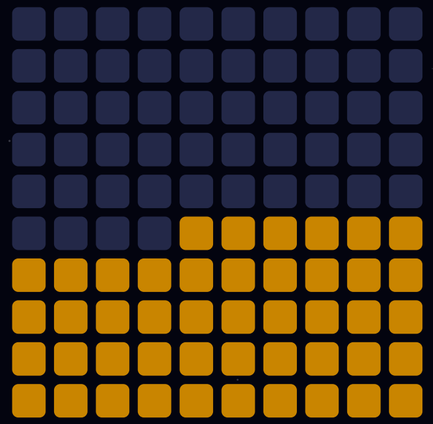
คนอายุหกสิบปีขึ้นไป

ส่วนในประชากร



18.7%

ส่วนในปีสุขภาพดีที่สูญเสีย



45.5%

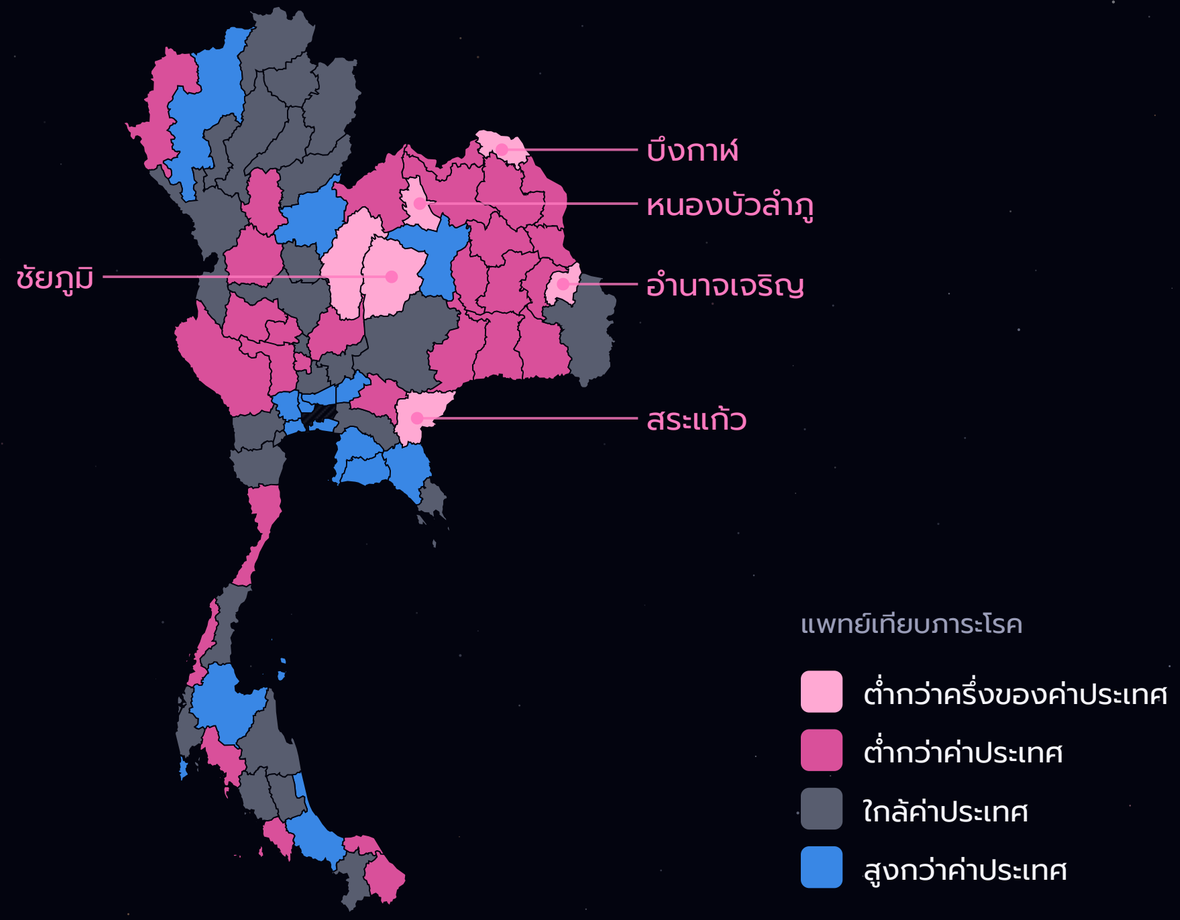
พ.ศ. 2556–2568 ภาระโรคที่คำนวณ +21.1% ประชากร +2.0%

ให้อัตราของแต่ละวัยคงเดิม

แพทย์อยู่มากในจังหวัดที่ป่วยน้อยกว่า

-0.111 ค่าติดลบสรุปทิศทางนี้

แผนที่: แพทย์ทุกสังกัดต่อประชากรที่ให้น้ำหนักตามภาระโรค เทียบกับประเทศ · พ.ศ. 2568



ภาระโรครายจังหวัด BOD 2022 (IHPP) · ภาระคาดหมายตรึงอัตรารายอายุ · แผนที่: แพทย์ทุกสังกัด พ.ศ. 2568 (รายงานทรัพยากรสาธารณสุข) ต่อประชากรที่ถ่วงด้วยภาระโรคปรับอายุ เทียบค่าประเทศ · รายงานการศึกษา บทที่ 4

101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สอง · ทำไมความเหลื่อมล้ำสะสม

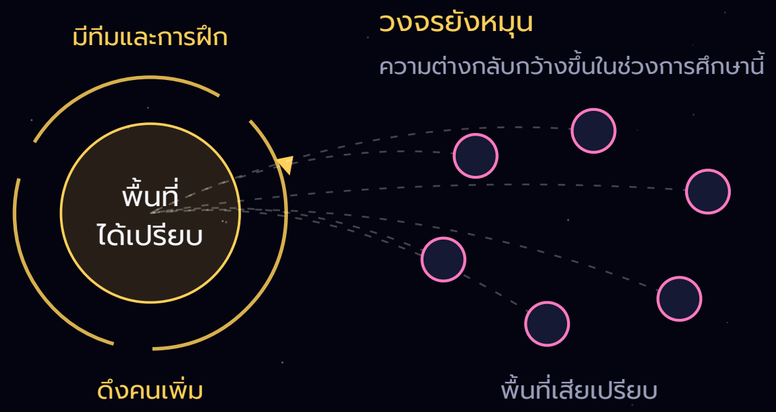
แผนภาพเชิงแนวคิด

พื้นที่ที่พร้อมยิ่งได้คนเพิ่ม ต้องมีนโยบายช่วยพื้นที่ที่ขาด

วงจรของ Myrdal: พื้นที่ที่มีทีมและการฝึกดึงคนเพิ่ม
คนที่เพิ่มช่วยขยายบริการและการฝึก จึงยิ่งดึงคนได้
ต้องมีนโยบายช่วยพื้นที่ที่เสียเปรียบ

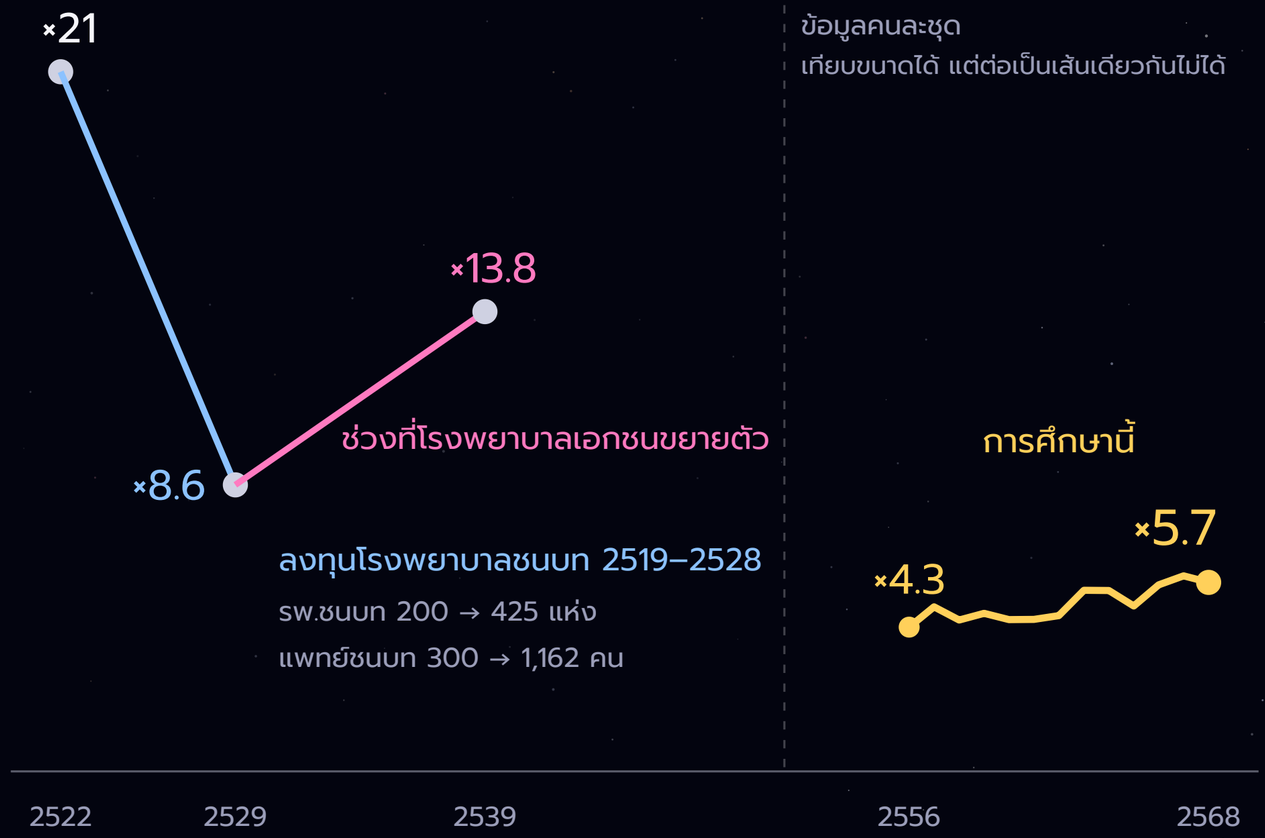
ความต่างแคบลงในช่วงที่**รัฐตัดสินใจลงทุน** ไม่ได้แคบลงเองตามเวลา
ทั้งการให้แพทย์ชดใช้ทุนและการลงทุนโรงพยาบาลชนบท
ข้อมูลนี้ยังแยกผลของแต่ละนโยบายไม่ได้

ในข้อมูลของการศึกษานี้ แม้แพทย์รวมเพิ่มมาก ความต่างกลับกว้างขึ้นจาก **4.3** เป็น **5.7 เท่า**



แพทย์ต่อประชากร กรุงเทพฯ สูงกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือกี่เท่า

ผลจากข้อมูล



ช่วงหลังเป็นข้อมูลของการศึกษานี้ (บุคลากรทุกสังกัด ประชากรทะเบียนราษฎร) คนละชุดกับในอดีต เทียบได้ในระดับขนาด
ประชากรตามทะเบียนของกรุงเทพฯ ต่ำกว่าคนที่อยู่จริง ค่ากรุงเทพฯ จึงสูงกว่าที่เป็นจริง

Myrdal 1957 · Wibulpolprasert & Pengpaibon 2003 · ช่วง พ.ศ. 2556–2568 จากข้อมูลของการศึกษานี้ (บุคลากรทุกสังกัด ทะเบียนราษฎร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด) · รายงานการศึกษา บทที่ 1 และ 4 · วงจรเป็นแผนภาพเชิงแนวคิด เส้นประยังต้องตรวจสอบ

101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สอง · ทำไมความเหลื่อมล้ำสะสม ● ผลจากข้อมูล

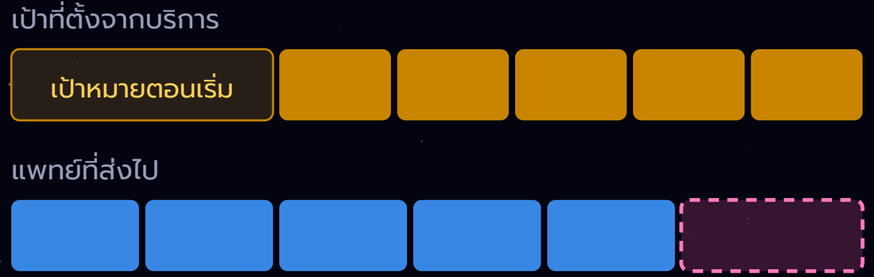
ทรัพยากรดึงทรัพยากร: ที่ที่มีพร้อมยิ่งได้เพิ่ม

ทีม การฝึก และตำแหน่งยังกระจุกอยู่ในบางพื้นที่

ถ้าใช้บริการที่ทำได้เป็นเกณฑ์เดียว **เพิ่มแพทย์แล้วบริการเพิ่ม เป้าที่ตั้งจากบริการจึงเพิ่มตาม** ส่วนขาดจึงลดได้น้อย

แพทย์เพิ่มหนึ่งคน

เป้าหมายเพิ่ม 0.88 คน



ช่องฟ้าคือแพทย์หนึ่งคน ช่องทองทึบคือเป้าที่เพิ่มตาม · ผลจากแบบจำลอง

แพทย์เฉพาะทาง

63.5%

อยู่ในสถานพยาบาลหนึ่งในสิบที่มีแพทย์เฉพาะทางมากที่สุด

จาก 61.6% ใน พ.ศ. 2564

ตำแหน่งที่มีงบจ้าง

×3.4

ตำแหน่งแพทย์กระทรวงต่อประชากร

จังหวัดสูงสุดเทียบต่ำสุด



เตียงกับวันนอน

เตียงมากขึ้น 1%

วันนอนมากขึ้น 0.708%

ความสัมพันธ์ ไม่ใช่ผลเชิงสาเหตุ

ตำแหน่งว่าง

18.9%

ใน รพ.ชุมชนขนาดเล็ก

รพ.ศูนย์ 5.6%

แพทย์เฉพาะทาง ทุกสังกัด ไม่รวมแพทย์ทั่วไป พ.ศ. 2564–2567 · ตำแหน่ง จ.18 ณ 1 มิ.ย. 2569 · รายงานการศึกษา บทที่ 4 และ 5

101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

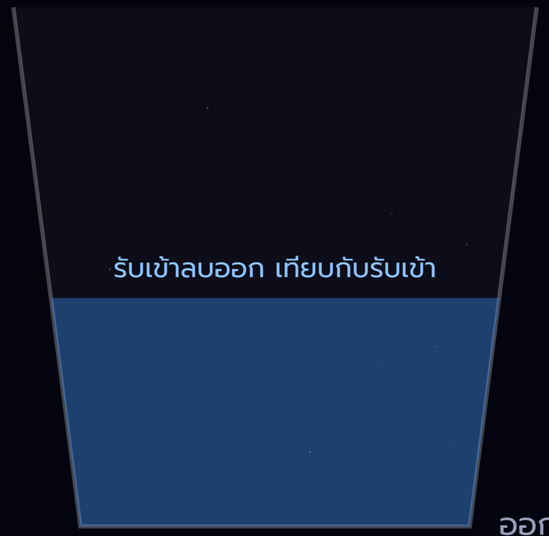
สอง · ทำไมความเหลื่อมล้ำสะสม ● ผลจากข้อมูล

ถังที่รั่ว: ผลิตเพิ่มอย่างเดียวไม่พอ

พยาบาลที่รับเข้ามาจำนวนมาก ต้องทดแทนคนที่ออกไป จึงเหลือคนเพิ่มไม่มาก

ต่อพยาบาลร้อยคนต่อปี รับเข้า **9.57** ครั้ง ออก **8.06** ครั้ง การออกส่วนใหญ่เป็นการลาออก

แพทย์



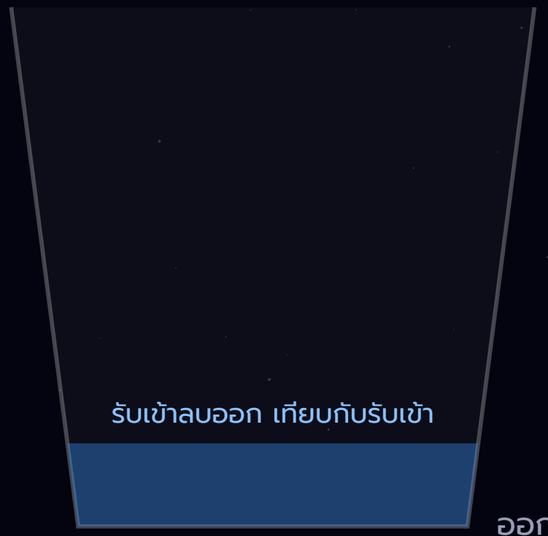
รับเข้า 19,744 ครั้ง

0.56

เหตุการณ์ออก ÷ รับเข้า

ออก 11,136 ครั้ง

พยาบาลวิชาชีพ



รับเข้า 99,365 ครั้ง

0.84

เหตุการณ์ออก ÷ รับเข้า

ออก 83,706 ครั้ง

นับเป็นครั้ง คนเดิมอาจนับซ้ำ · ระดับน้ำคือรับเข้าลบออก เทียบกับรับเข้า ไม่ใช่การติดตามว่าผู้รับใหม่ยังอยู่กี่คน

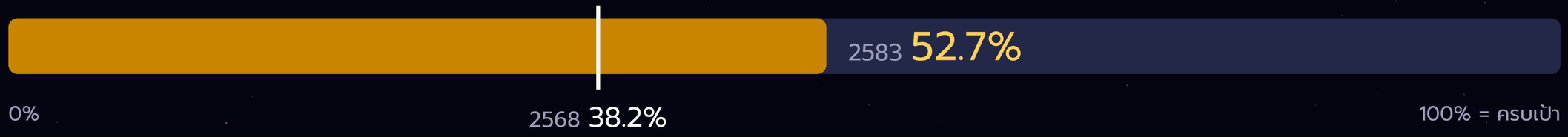
101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สาม · เพิ่มตำแหน่งให้พื้นที่ขาด ◆ ผลจากแบบจำลอง

สูตรบอกว่าใครขาดมากกว่า ส่วนขาดเท่าใดต้องกำหนดเป้าหมาย

สมมติว่ามีผู้ตอบรับเริ่มงานปีละ 2,000 คน ถึงปี 2583 ทุกจังหวัดยังต่ำกว่าเป้าตัวอย่าง ย้ายคนกันก็ไม่ลดส่วนขาดรวม

จำนวนแพทย์กระทรวงเป็นร้อยละของเป้าตัวอย่าง 1:1,000 ประชากรที่กระทรวงรับผิดชอบ (ไม่ใช่มาตรฐานกระทรวง)



แพทย์กระทรวง 22,685 → 29,214 คน (2568 → 2583) · เป้าตัวอย่างปี 2568 ต้องมี 59,316 คน

จำนวนแพทย์ที่ยังขาดจากเป้า ปี 2583



ทุกจังหวัดยังต่ำกว่าเป้า ย้ายไปเติมที่หนึ่งก็ทำให้อีกที่ขาด ส่วนขาดรวมจึงไม่ลด · ผลจากแบบจำลอง

101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สาม · เพิ่มตำแหน่งให้พื้นที่ขาด ◆ ผลจากแบบจำลอง

ตำแหน่งเต็มแล้ว แพทย์ใหม่ลงได้เฉพาะที่ว่าง

มีตำแหน่งแพทย์ที่มีงบจ้าง 28,925 ตำแหน่ง ว่าง 2,813 ตำแหน่ง รับผู้ปฏิบัติงานเพิ่มได้ราว 2,444 คน ถ้าไม่เพิ่มตำแหน่ง แบบจำลองพบว่าจะเต็มปี 2572

ไม่มีตำแหน่งว่าง ก็รับแพทย์ใหม่ไม่ได้ จะแบ่งแพทย์ใหม่ด้วยเกณฑ์ใด 19 จังหวัดที่ต่ำสุดในปี 2583 ก็ได้**เท่ากัน**

เกณฑ์แบ่งแพทย์ใหม่ · แพทย์เทียบเป้าใน 19 จังหวัดที่ต่ำสุดในปี 2583

ประชากร	33.7%
บริการที่คำนวณให้เทียบกันได้	33.7%
ภาระโรค	33.7%

เท่ากันทุกสูตร

ถ้าไม่เพิ่มตำแหน่ง · แต่ละช่องคือหนึ่งจังหวัด

เต็มปี 2572

ภาพนี้คือ พ.ศ. 2583

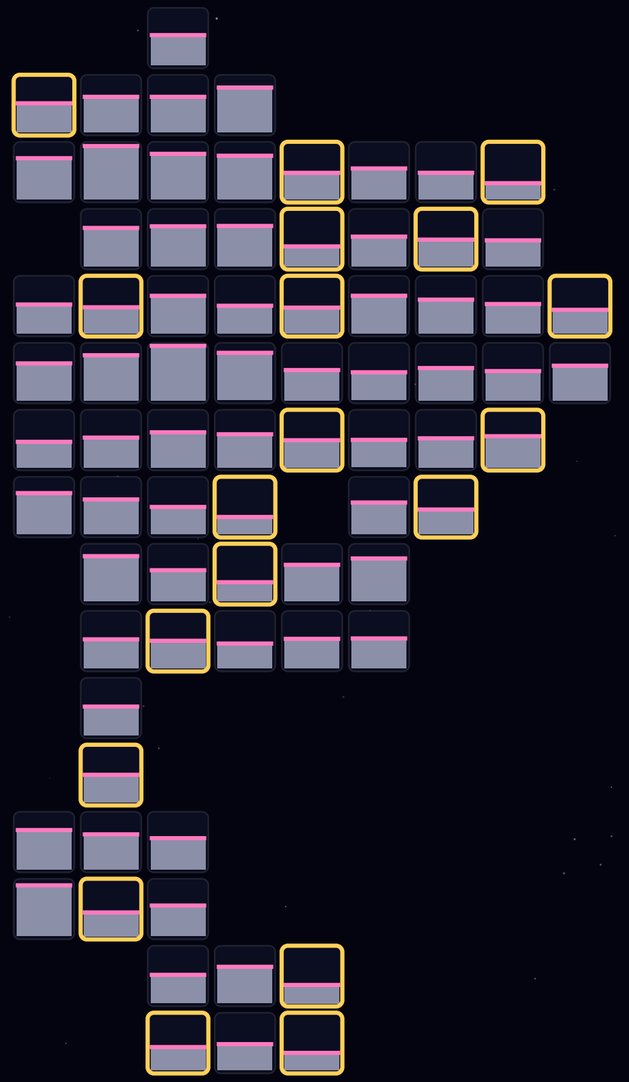
- แพทย์เต็มตำแหน่งแล้ว
- จำนวนที่ตำแหน่งรองรับได้
- 19 จังหวัดที่ขาดที่สุดในปีตั้งต้น

แพทย์ใหม่ที่ไม่มีตำแหน่งรองรับ (สะสม)

5,442

คน ถึง พ.ศ. 2583

ไม่ได้แปลว่าตกงานทั้งหมด



101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สาม · เพิ่มตำแหน่งให้พื้นที่ขาด ◆ ผลจากแบบจำลอง

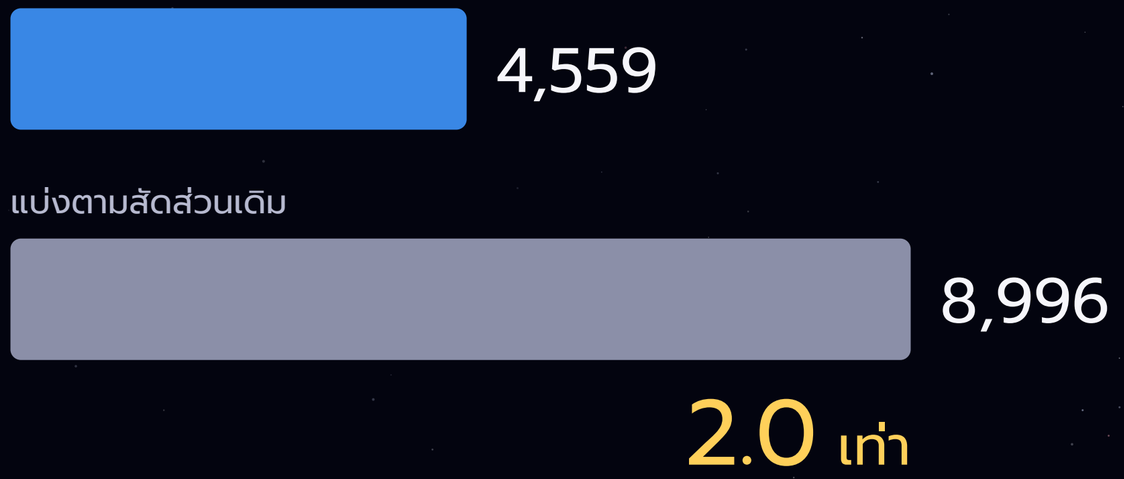
เพิ่มตำแหน่งให้พื้นที่ขาดก่อน ใช้เพียงครึ่งเดียวก็ได้ผลเท่ากัน

เพิ่มตำแหน่งที่มีงบจ้างร้อยละห้าทุกห้าปี รวม 4,559 ตำแหน่งในสิบห้าปี เปรียบเทียบแบ่งตามสัดส่วนเดิมกับให้พื้นที่ขาดก่อน

เพิ่มตำแหน่งเท่ากัน 4,559 ตำแหน่ง · ผลปี 2583

	แบ่งตามสัดส่วนตำแหน่งเดิม		ให้พื้นที่ขาดก่อน
19 จังหวัดที่ต่ำสุดในปี 2583 % ของเป้า	39.0%	→	43.7%
ความต่างระหว่างจังหวัด Gini ยิ่งต่ำยิ่งต่างกันน้อย	0.127	→	0.090
แพทย์ตามสัญญา ที่ไม่มีตำแหน่งให้กลับภูมิลำเนา (คน)	590	→	3

ตำแหน่งที่ต้องเพิ่ม เพื่อให้กลุ่มจังหวัดที่ขาดได้ผลเท่ากัน



รอบตำแหน่ง 2570–2574 ที่กำลังจัดทำ

24 จังหวัด ควรได้ตำแหน่งใหม่ตรงกันในเกณฑ์ที่ทดลอง

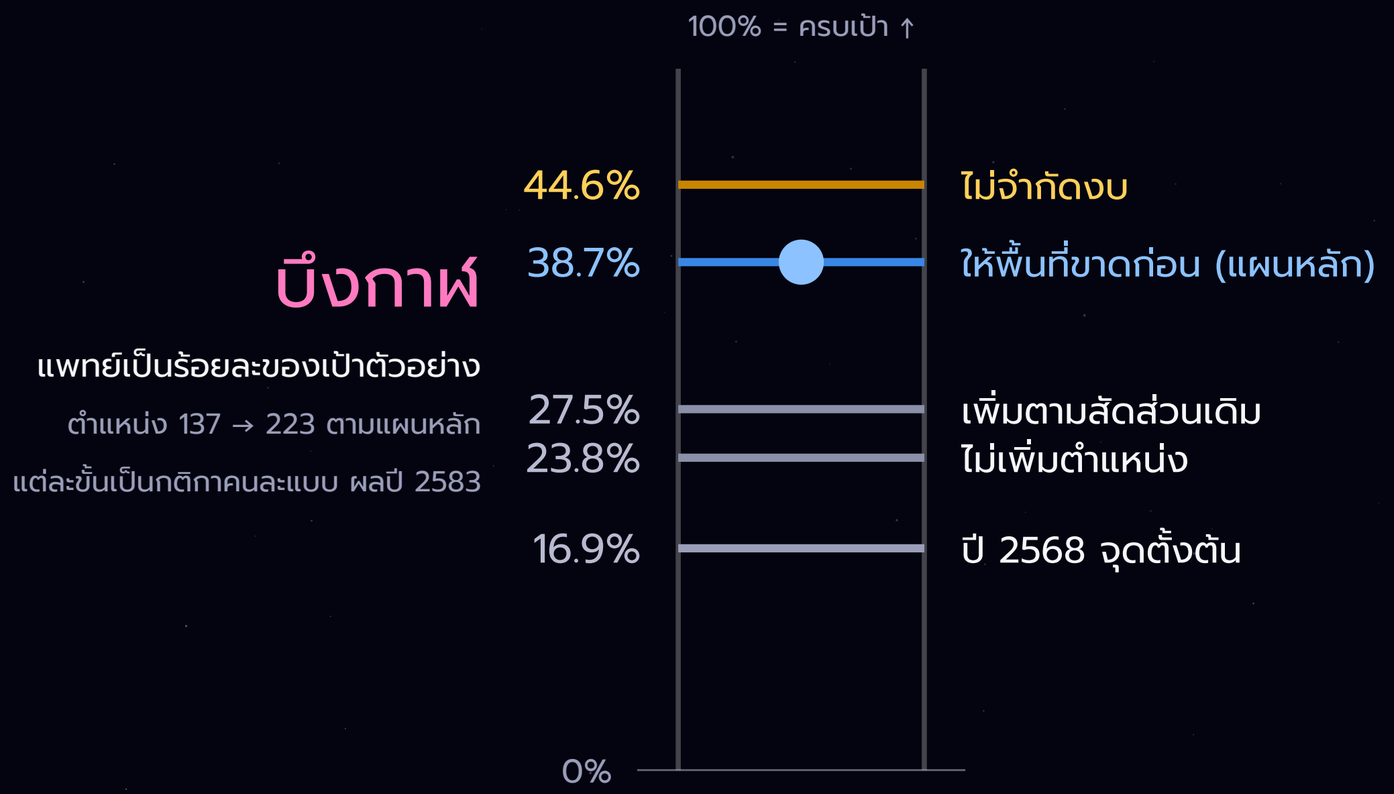
ขาดแพทย์ 16 จังหวัด · ต้องรับแพทย์ตามสัญญาหรือผู้กลับจากฝึกอบรม 8 จังหวัด

101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สาม · เพิ่มตำแหน่งให้พื้นที่ขาด ◆ ผลจากแบบจำลอง

บันไดของบึงกาฬ

บึงกาฬมีแพทย์กระทรวง 72 คน ตำแหน่งที่มีงบจ้าง 137 ตำแหน่ง แพทย์ออกราวร้อยละ 13.4 ต่อปี
แต่ละขั้นบันไดคือผลจำลองเมื่อใช้กติกาต่างกัน



แพทย์ของบึงกาฬเป็นร้อยละของเป้าตัวอย่าง พ.ศ. 2583 ภายใต้แต่ละกติกา · แผนหลักเพิ่มตำแหน่งเป็น 223 ตำแหน่ง · ผลตามสมมติฐาน ไม่ใช่การพยากรณ์ · รายงานการศึกษา บทที่ 5

101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สาม · เพิ่มตำแหน่งให้พื้นที่ขาด ◆ ผลจากแบบจำลอง

ใครจ่ายค่าจ้าง สำคัญกว่าจ้างแบบไหน

ลองลดตำแหน่งข้าราชการที่ว่าง แล้วจ้างลูกจ้างทดแทนให้รับคนได้เท่าเดิม ใครจ่ายและให้พื้นที่ใดก่อน เปลี่ยนผลได้มาก

ถ้าโรงพยาบาลจ้างจากรายได้ของตัวเอง ลูกจ้างจะไปอยู่ที่จังหวัดที่มีบริการมาก ถ้า**ส่วนกลางจ่ายและให้พื้นที่ขาดก่อน** พื้นที่รายได้น้อยจึงรับคนได้ ไม่ต้องปล่อยให้จำนวนคนขึ้นกับรายได้โรงพยาบาล

ลูกจ้างรอบแรกที่อยู่ใน 19 จังหวัดที่ขาดที่สุดในปีตั้งต้น

17%

โรงพยาบาลจ่าย

19 จังหวัดที่ต่ำสุดในปี 2583 แพทย์ได้ 39.6% ของเป้า

49%

ส่วนกลางจ่าย

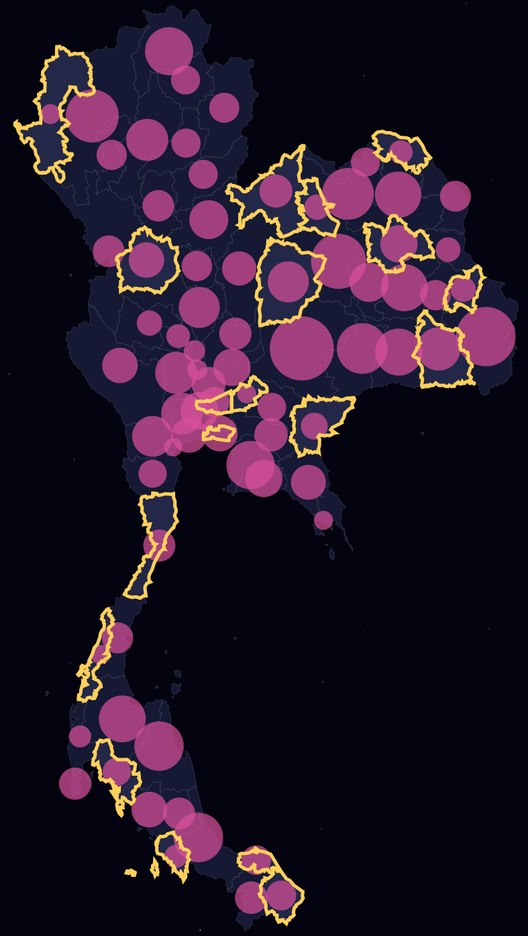
19 จังหวัดที่ต่ำสุดในปี 2583 แพทย์ได้ 48.8% ของเป้า

เส้นทอง = 19 จังหวัดที่ขาดที่สุดในปีตั้งต้น

ขนาดวง = จำนวนลูกจ้างในจังหวัด

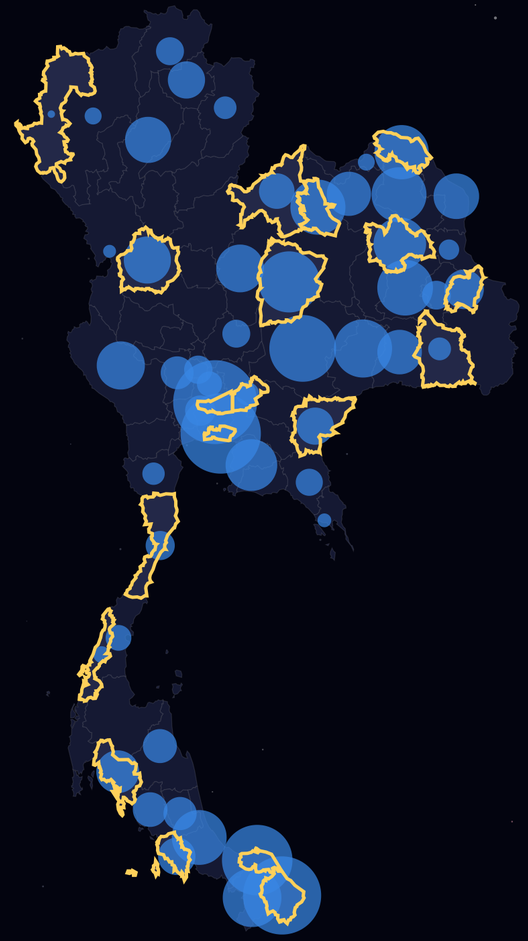
โรงพยาบาลจ่ายจากรายได้ของตน

ใช้ปริมาณบริการประมาณส่วนแบ่งรายได้
เพราะไม่มีข้อมูลการเงินโรงพยาบาล



ส่วนกลางจ่าย ให้พื้นที่ขาดก่อน

จัดลูกจ้างให้จังหวัดที่ขาดก่อน
ไม่ขึ้นกับรายได้ของโรงพยาบาล



101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

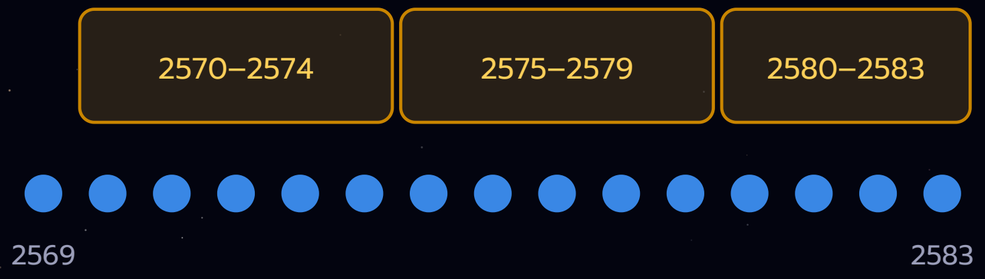
สาม · เพิ่มตำแหน่งให้พื้นที่ขาด ◆ ผลจากแบบจำลอง

จัดแพทย์ใหม่ทุกปี และบอกข้อจำกัดของแบบจำลอง

ทบทวนตำแหน่งทุกห้าปี จัดแพทย์ใหม่ทุกปี
ตามตำแหน่งที่ว่างจริง

เรากำหนดเกณฑ์ไว้ก่อนทดสอบกับข้อมูลอดีต ผ่านหนึ่งด้าน ไม่ผ่านสองด้าน จึงใช้**เปรียบเทียบทางเลือกตามสมมติฐาน**ได้ แต่ไม่ใช้เป็นรายชื่อจัดสรรตายตัว รายชื่อจังหวัดต้องทบทวนทุกปี

ทบทวนตำแหน่ง · ทุกห้าปี



จัดแพทย์ใหม่ · ทุกปี
ตามตำแหน่งที่ว่างจริง

	กำหนดล่วงหน้าตลอดสิบห้าปี	จัดใหม่ทุกปี
แพทย์ที่แผนส่งไปจังหวัดไม่มีตำแหน่งว่าง ยอดสะสมสิบห้าปี เฉลี่ยต่ออนาคตจำลองหนึ่งแบบ	1,193	→ 1,003
แพทย์เทียบเป้าใน 19 จังหวัด ที่ต่ำสุดในปี 2583 (% ของเป้า)	42.2%	→ 44.4%

กำหนดล่วงหน้า: เฉลี่ยจาก 500 อนาคตจำลอง
จัดใหม่ทุกปี และแถว % ของเป้า: เทียบคู่ใน 60 อนาคตแรกของชุดเดียวกัน

ทดสอบกับข้อมูลอดีต · เกณฑ์กำหนดก่อนทดสอบ

1 · จำนวนแพทย์รายจังหวัดคลาดเคลื่อนเท่าใด — ผ่าน
28.1 คนต่อจังหวัด · ค่าเดิม 33.3 · ตามประชากร 32.8

2 · ค่าจริงอยู่ในช่วงที่คาดไว้บ่อยพอหรือไม่ — ไม่ผ่าน
0.44 · เกณฑ์ 0.80–0.98

3 · รายชื่อจังหวัดที่ขาดตรงกับข้อมูลจริงหรือไม่ — ไม่ผ่าน
0.59 · เกณฑ์ 0.60 · รายชื่อเดิม 0.72

500 อนาคตจำลอง (เทียบคู่กับการจัดใหม่ทุกปีใน 60 อนาคตแรก) · ทดสอบกับข้อมูลอดีตตามเกณฑ์ที่กำหนดก่อนทดสอบ · รายงานการศึกษา บทที่ 5

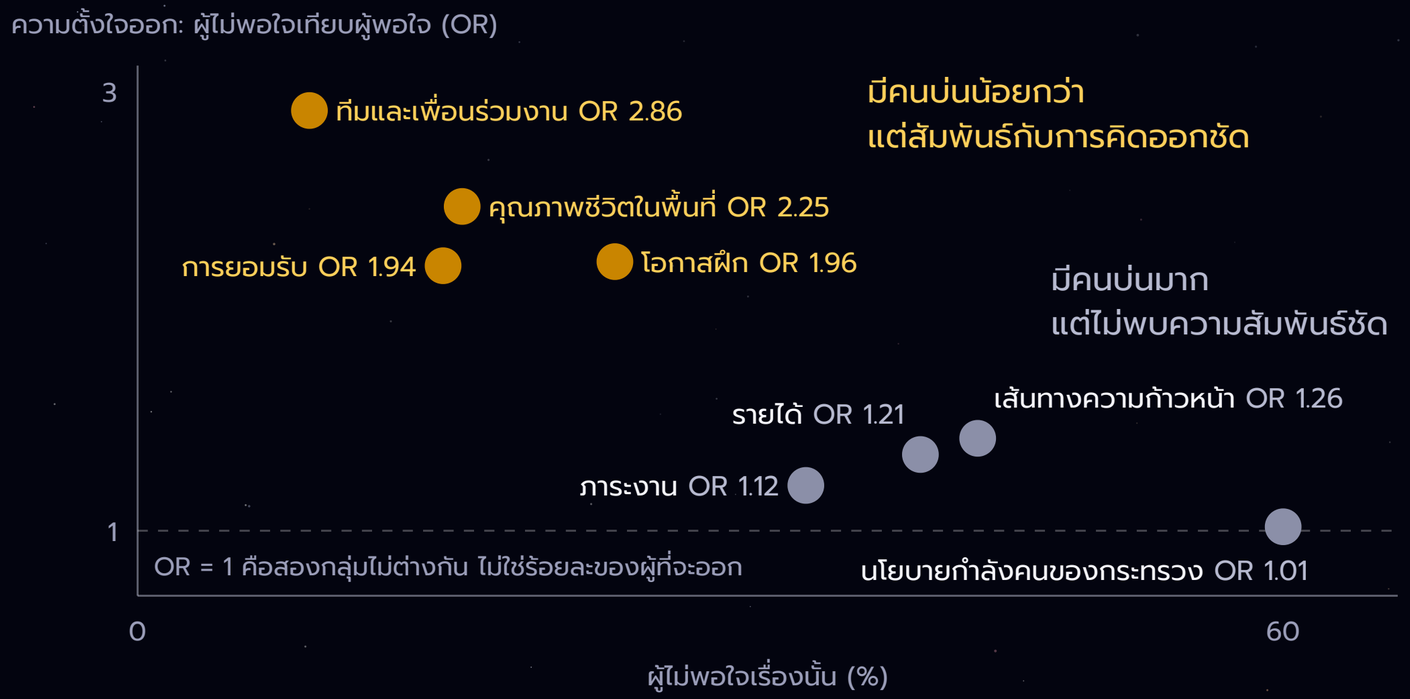
101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สี่ · ใครรับภาระ ● ผลจากข้อมูล

เรื่องที่คนบ่นมาก อาจไม่ใช่เรื่องที่สัมพันธ์กับการคิดออก

สำรวจผู้ปฏิบัติงาน 734 คน จาก 110 หน่วยบริการใน 66 จังหวัด
ร้อยละ 16 คิดออกจากราชการหรือสังกัดภายในสามปี

ผู้ทำงานในพื้นที่ทุรกันดารและผู้ที่การจ้างไม่มั่นคงคิดออกมากกว่า
ส่วนการทำงานในจังหวัดบ้านเกิดสัมพันธ์กับการคิดย้ายพื้นที่น้อยลง แต่ไม่พบความสัมพันธ์ชัดกับการออกจากสังกัด



ปัจจัยเชิงโครงสร้าง

พื้นที่ทุรกันดาร OR 2.35
→ คิดออกจากสังกัดมากกว่า

การจ้างไม่มั่นคง OR 2.26
→ คิดออกจากสังกัดมากกว่า

ทำงานจังหวัดบ้านเกิด OR 0.44
→ คิดย้ายพื้นที่น้อยกว่า

ความสัมพันธ์จากผู้ที่ยังทำงาน ไม่ใช่เหตุและผล

101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สี่ · ใครรับภาระ ◐ การตีความของคณะวิจัย

ตัวเลขว่าขาดน้อยลง อาจซ่อนงานที่ย้ายไปให้ครอบครัว

ส่วนขาดที่ลดลงเกิดได้สามทาง คือทำงานได้มากขึ้น ลดเป้าหมายลง หรือย้ายงานให้ครอบครัวและวิชาชีพอื่น ต้องดูว่าเกิดจากทางใด

รายงานจึงควรบอกคู่กันว่า เพิ่มทรัพยากรอะไร เปลี่ยนเป้าหมายอะไร และใครรับงานเพิ่ม

งานดูแลผู้สูงอายุที่บ้านตกอยู่กับครอบครัว

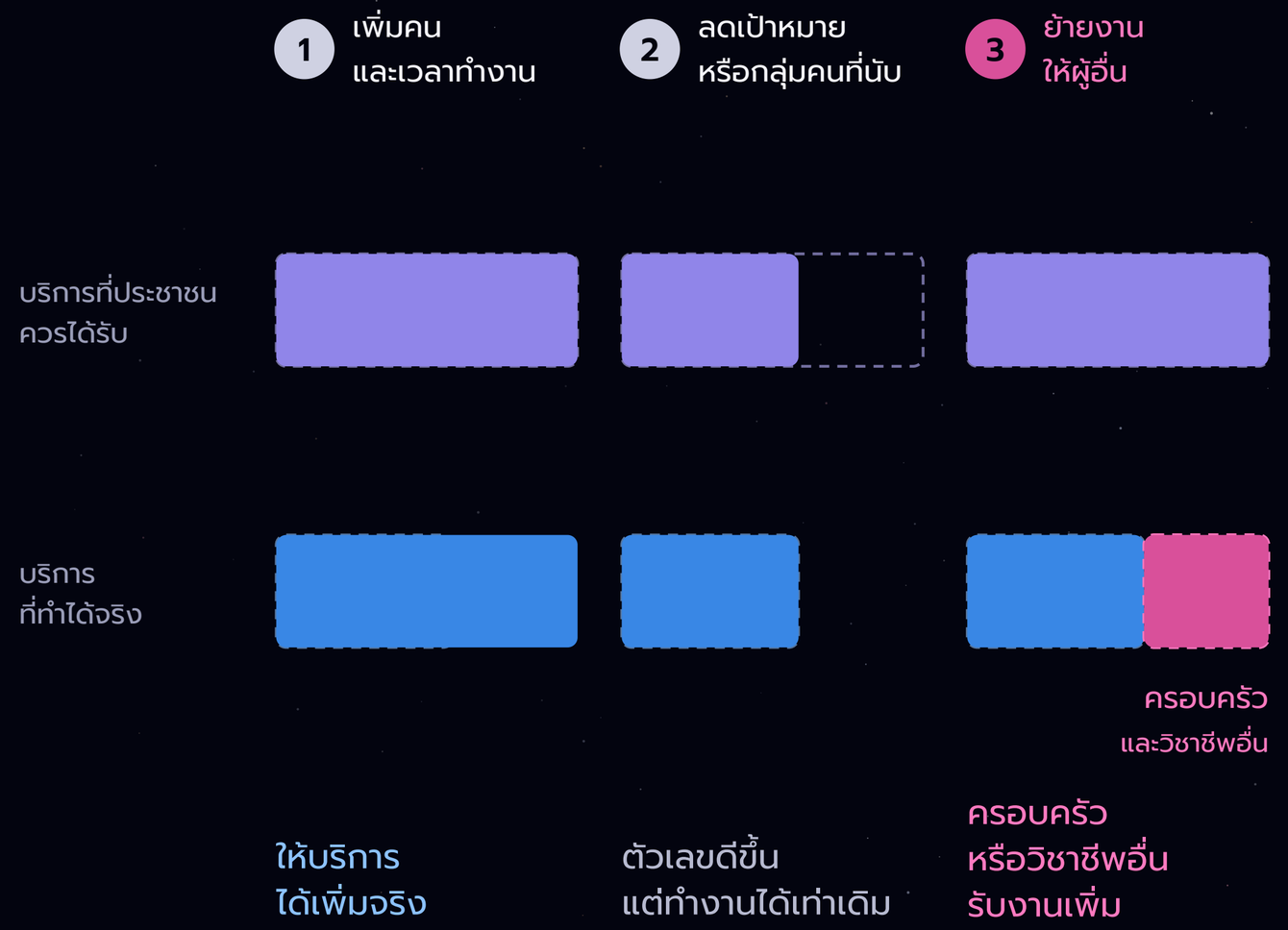
92–94%

ผู้ดูแลหลักของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เป็นคนในครอบครัว

34,310

คนในครอบครัวลาออกจากงาน มาดูแลผู้สูงอายุ

สำรวจผู้สูงอายุ สสช. 2567 · รายงานการดูแลระยะยาวในชุมชน 2569



101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

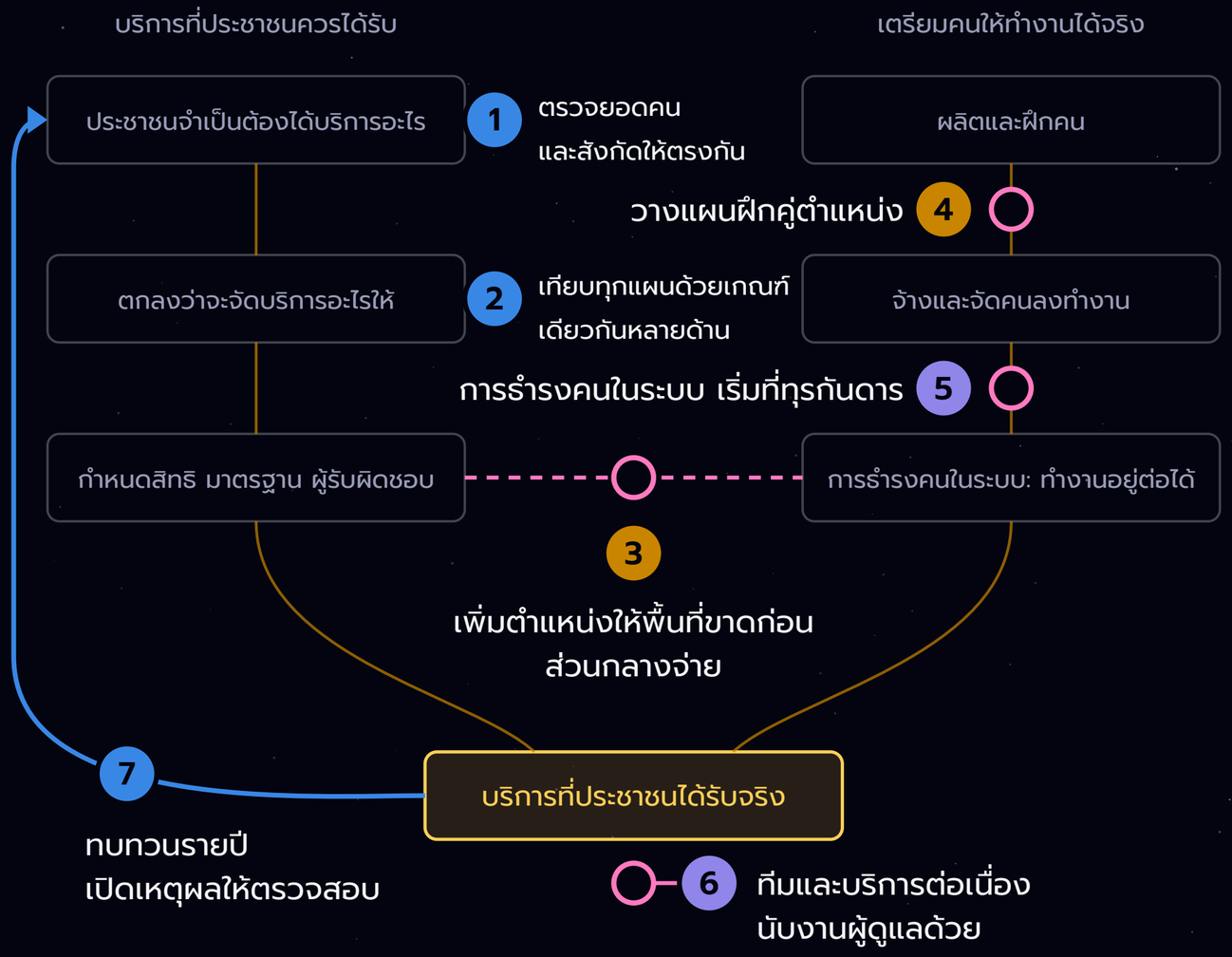
ข้อเสนอ · การตีความของคณะวิจัย

ข้อเสนอเจ็ดข้อ เพื่อแก้ปัญหาสี่จุด

ข้อมูล ตำแหน่ง การฝึก และการธำรงคนในระบบต้องทำต่อกัน จึงจะเกิดบริการที่ประชาชนได้รับจริง

ตัวเลขคือลำดับที่ต้องทำ · สีบอกแนวคิดที่ใช้

- **การจัดให้มีบริการทางสังคม**
  ใครควรได้บริการอะไร
- **วงจรสะสม (Myrdal)**
  นโยบายช่วยพื้นที่เสียเปรียบ
- **เศรษฐศาสตร์แรงงาน**
  ช่วยคนอยู่ต่อและนับผู้รับภาระ



101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ข้อมูลบอกผลและภาระของแต่ละทางเลือก แต่เลือกแทนเราไม่ได้

1 ความจำเป็นใดควรถูกนับก่อน

2 ใครควรเป็นผู้จ้าง และอะไรกำหนดว่าพื้นที่รับคนได้เท่าใด

3 ใครรับภาระของความไม่เพียงพอระหว่างรัฐ ผู้ทำงาน ครอบครัว และชุมชน

4 ใครควรมีสิทธิ์ตัดสินว่าเท่าใดจึงเพียงพอและฉันทามติควรสร้างผ่านช่องทางใด

ตรวจทุกผล และลองเปลี่ยนแผนเองได้ใน
Workforce Lab

psitthirat.github.io/HRH-model

ขอบคุณหน่วยงานที่ให้ข้อมูล และผู้ปฏิบัติงานทุกท่านที่ตอบแบบสำรวจ

101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)



101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)